

CAPÍTULO 4.8

Fiebre Reumática

PERFIL EUNACOM 1.01.1.008

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La **Fiebre Reumática** (o Enfermedad Reumática Activa) es una complicación inflamatoria, sistémica y no supurativa que aparece tras una infección faríngea por el **Streptococo beta hemolítico del grupo A** (*Streptococcus pyogenes*). Aunque su incidencia ha disminuido drásticamente gracias al uso de antibióticos en la **Faringoamigdalitis**, sigue siendo una causa importante de cardiopatía adquirida en adultos jóvenes en países en vías de desarrollo.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: No se trata de una infección directa del corazón o las articulaciones, sino de una respuesta autoinmune por **mimetismo molecular**. Los anticuerpos generados contra la proteína M del estreptococo presentan reacción cruzada con antígenos propios en el tejido cardíaco (sarcolema), válvulas, articulaciones y ganglios basales.

Criterios Diagnósticos (Criterios de Jones)

- El diagnóstico de la fiebre reumática es fundamentalmente clínico y se basa en los **Criterios de Jones**. Para establecer el diagnóstico de un primer brote, se requiere la evidencia de una infección estreptocócica previa (ASLO elevado, cultivo faríngeo o test rápido de antígeno) más:
- 2 criterios mayores.
- 1 criterio mayor y 2 menores.

1. Criterios Mayores

Son las manifestaciones clínicas más específicas de la enfermedad:

TABLA 4.8.1: CRITERIO VS DESCRIPCIÓN CLÍNICA

CRITERIO	DESCRIPCIÓN CLÍNICA
Carditis	Afectación de todas las capas del corazón (Pancarditis). Lo más frecuente es la valvulitis (especialmente de la válvula mitral). Puede presentarse como soplos nuevos, Insuficiencia Cardíaca o Pericarditis Aguda .
Artritis	Clásicamente es una poliartritis migratoria que afecta a grandes articulaciones (rodillas, tobillos, codos, muñecas). Es exquisitamente dolorosa pero responde muy bien a los AINES.
Corea de Sydenham	También llamada "Corea Menor". Se caracteriza por movimientos involuntarios, rápidos y desordenados (parecidos a un baile), debilidad muscular y labilidad emocional. Es una manifestación tardía.
Eritema Marginado	Manchas rosadas con bordes nítidos y centro claro (aspecto de "tiro al blanco"), no pruriginosas, localizadas principalmente en el tronco y extremidades proximales.
Nódulos Subcutáneos	Nódulos pequeños, firmes y neumáticos, indoloros, que aparecen sobre prominencias óseas o tendones (habitualmente en codos y rodillas).

2. Criterios Menores

Son hallazgos inespecíficos que apoyan el diagnóstico: - **Fiebre**. - **Artralgias** (dolor articular sin signos de inflamación). - Elevación de reactantes de fase aguda: **Proteína C Reactiva (PCR)** y **Velocidad de Sedimentación Globular (VHS)**. - Alteraciones electrocardiográficas: Prolongación del **intervalo PR** (bloqueo AV de primer grado).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM, recuerda que la **Corea de Sydenham** puede ser el único criterio presente y es suficiente para el diagnóstico incluso si aparece meses después de la infección faríngea, ya que tiene un periodo de latencia muy largo.

Manifestaciones Cardíacas: La Carditis Reumática

- Es la manifestación más grave por el potencial de secuelas crónicas. Puede presentarse como:
- Endocarditis (Valvulitis):** Es la más común. La válvula más afectada es la **mitral**, seguida de la **aórtica**. En la fase aguda genera insuficiencia; en la fase crónica, la cicatrización produce **Estenosis Mitral**.
- Miocarditis:** Puede llevar a una falla cardíaca aguda.
- Pericarditis:** Se manifiesta por dolor torácico y frote pericárdico.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La carditis reumática es la única manifestación de la fiebre reumática que puede dejar secuelas permanentes y progresivas. La artritis y la corea suelen resolverse por completo sin dejar daños crónicos.

Tratamiento del Brote Agudo

El manejo tiene tres pilares fundamentales:

- Erradicación del Streptococo:**
 - Se debe tratar la infección estreptocócica aunque ya no haya síntomas faríngeos.
 - El fármaco de elección es la **Penicilina Benzatina** (dosis única IM) o Penicilina V oral por 10 días. En alérgicos, se utilizan macrólidos.
- Tratamiento Antiinflamatorio:**
 - **AINES (Aspirina):** Es el tratamiento de elección para la artritis. Se utilizan dosis altas.
 - **Corticoides:** Se reservan para casos de carditis moderada a severa o cuando hay insuficiencia cardíaca franca, aunque su evidencia para prevenir daño valvular a largo plazo es limitada.
- Reposo:** Fundamental durante la fase aguda, especialmente si hay carditis, para disminuir la carga de trabajo del corazón.

Prevención y Profilaxis Secundaria

Una vez que un paciente ha tenido fiebre reumática, tiene un riesgo muy alto de recurrencia ante nuevas infecciones estreptocócicas, lo que agravaría el daño cardíaco.

Profilaxis Secundaria (Prevención de recurrencias)

Consiste en la administración de **Penicilina Benzatina IM cada 3 o 4 semanas**.

- Duración de la profilaxis:**
- Sin carditis:** Hasta los 21 años o 5 años tras el último brote (lo que dure más).
- Con carditis (sin secuela valvular):** Hasta los 21 años o 10 años tras el último brote (lo que dure más).
- Con carditis y secuela valvular persistente:** Hasta los 40 años o incluso de por vida si el riesgo de exposición es muy alto.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Pregunta frecuente: ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir la cardiopatía reumática crónica? Respuesta: El tratamiento antibiótico adecuado de toda **Faringoamigdalitis** bacteriana (Prevención Primaria).

Resumen de Seguimiento

El paciente debe ser derivado a cardiología para el seguimiento de la función valvular mediante ecocardiografía, especialmente si hubo evidencia de carditis en el brote agudo. Las secuelas valvulares como la **Estenosis Mitral** pueden tardar años o décadas en manifestarse clínicamente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niña de 10 años consulta por fiebre, poliartritis migratoria de grandes articulaciones y soplo de insuficiencia mitral nuevo, 3 semanas después de faringoamigdalitis estreptocócica. ASO elevado."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Fiebre Reumática: cumple Criterios de Jones Modificados: 2 criterios mayores (Carditis + Poliartritis) con evidencia de infección estreptocócica previa (ASO elevado). Tratamiento agudo: Penicilina Benzatina IM + AINEs. Profilaxis secundaria: Penicilina Benzatina 1.2 MUI IM cada 4 semanas. Duración: 10 años o hasta los 40 años si hubo carditis con secuela valvular.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La fiebre reumática ocurre 2-4 semanas post faringoamigdalitis por *Streptococcus pyogenes*
- Se produce por mimetismo molecular entre proteína M estreptocócica y tejidos del huésped
- Los criterios de Jones requieren evidencia de infección estreptocócica + 2 mayores o 1 mayor + 2 menores
- La poliartritis migratoria es la manifestación más frecuente; la carditis es la más grave
- La válvula mitral es la más frecuentemente afectada
- La insuficiencia mitral aguda es la lesión valvular más frecuente en el ataque agudo
- La profilaxis secundaria con penicilina benzatina previene recurrencias que agravan el daño valvular
- La corea de Sydenham puede aparecer meses después y no requiere evidencia de infección reciente

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIEBRE REUMÁTICA)

PREGUNTA 1

Niño de 10 años consulta por fiebre y dolor articular migratorio de rodillas y tobillos que apareció 3 semanas después de una faringoamigdalitis. ASO elevada. Al examen: soplo de insuficiencia mitral nuevo. ¿Cuántos criterios mayores de Jones tiene este paciente?

- ☐ A) Uno
- ☐ B) Dos
- ☐ C) Tres
- ☐ D) Cuatro
- ☐ E) Ninguno, no cumple criterios de Jones

PREGUNTA 2

¿Cuál es la válvula más frecuentemente afectada en la fiebre reumática?

- ☐ A) Válvula aórtica
- ☐ B) Válvula mitral
- ☐ C) Válvula tricúspide
- ☐ D) Válvula pulmonar
- ☐ E) Todas se afectan por igual

PREGUNTA 3

Paciente con antecedente de fiebre reumática con carditis y secuela valvular mitral. ¿Cuál es la duración recomendada de la profilaxis secundaria con penicilina benzatina?

- ☐ A) 5 años o hasta los 21 años
- ☐ B) Solo durante la infancia
- ☐ C) 10 años o hasta los 40 años
- ☐ D) No requiere profilaxis si ya tuvo cirugía valvular
- ☐ E) 2 años después del último episodio

RESUMEN: FIEBRE REUMÁTICA

La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica que ocurre como complicación tardía de una faringoamigdalitis por *Streptococcus pyogenes* (grupo A). Se produce por reactividad cruzada entre antígenos estreptocócicos y tejidos del huésped, especialmente el corazón. Afecta principalmente a niños entre 5 y 15 años en países en desarrollo. El diagnóstico se basa en los criterios de Jones: se requiere evidencia de infección estreptocócica reciente más 2 criterios mayores o 1 mayor + 2 menores. Los criterios mayores son carditis, poliartritis migratoria, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Los criterios menores incluyen fiebre, artralgias, elevación de reactantes de fase aguda y PR prolongado. La carditis es la manifestación más grave porque puede causar secuelas valvulares permanentes. El tratamiento agudo incluye penicilina benzatina para erradicar el estreptococo, aspirina para la artritis y corticoides para la carditis severa. La profilaxis secundaria con penicilina benzatina cada 3-4 semanas es fundamental para prevenir recurrencias que agravan el daño valvular. La duración de la profilaxis depende de la presencia y severidad de la carditis.